

infecciones bacterianas (impétigo, foliculitis, forúnculo, ántrax, celulitis y erisipela)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **infecciones bacterianas cutáneas** son patologías **frecuentes en atención primaria**, urgencias y hospitalización.

Pueden afectar **cualquier grupo etario**, aunque predominan en **niños, ancianos, diabéticos e inmunocomprometidos**.

La piel, al ser una barrera defensiva, puede verse invadida cuando se altera su integridad (heridas, rascado, maceración, picaduras, procedimientos quirúrgicos o dermatitis previas).

Los agentes más comunes son:

- **Staphylococcus aureus** (incluido *S. aureus* meticilino resistente, *SAMR*).
- **Streptococcus pyogenes** (grupo A β -hemolítico).

Estas bacterias colonizan la piel y mucosas, y pueden producir desde **infecciones superficiales autolimitadas (impétigo)** hasta **cuadros invasivos graves (celulitis, fasciitis necrotizante)**.

En Chile, el **MINSAL** enfatiza el diagnóstico clínico temprano y el tratamiento antimicrobiano racional, evitando el uso innecesario de antibióticos tópicos y sistémicos, sobre todo frente al aumento de resistencia.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La piel posee una flora residente que actúa como barrera inmunológica. Cuando la integridad cutánea se pierde, bacterias patógenas o comensales pueden penetrar las capas epidérmicas y dérmicas.

Factores predisponentes

- Microtraumas, picaduras o heridas quirúrgicas.
- Dermatitis previas (eczema, psoriasis, tiña).
- Maceración por humedad o mala higiene.

- Diabetes mellitus, insuficiencia venosa o linfedema.
- Inmunosupresión o desnutrición.

Mecanismos de infección

1. **Colonización y adherencia** bacteriana (proteínas de superficie).
2. **Invasión tisular** mediante enzimas (hialuronidasa, lipasas, proteasas).
3. **Respuesta inflamatoria local** con eritema, calor, dolor y edema.
4. **Diseminación sistémica** en casos graves o no tratados (bacteriemia, sepsis).

La **profundidad del compromiso cutáneo** define el tipo de infección:

Nivel afectado	Infección característica
Epidermis	Impétigo
Folículo piloso superficial	Foliculitis
Dermis profunda	Forúnculo / ántrax
Dermis y tejido celular subcutáneo	Celulitis / erisipela

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A continuación se resumen los principales cuadros clínicos bacterianos cutáneos, con su fisiopatología, manifestaciones y diagnósticos diferenciales.

3.1. Impétigo

Definición

Infección **superficial y contagiosa** de la epidermis, muy frecuente en **niños**, especialmente en verano o climas cálidos y húmedos.

Etiología

- **S. aureus** (causa más común).
- **S. pyogenes** o coinfección mixta.

Formas clínicas

1. Impétigo no ampolloso (clásico)

- Lesiones papulovesiculosas → pústulas → **costras melicéricas** (miel color dorado).
- Localización: cara, región perioral, nariz y extremidades.
- Poco dolor, pruriginoso.

2. Impétigo ampolloso

- Causado por cepas de *S. aureus* productoras de toxina exfoliativa.
- Ampollas flácidas que dejan erosiones costrosas.
- Más común en lactantes.

Diagnóstico diferencial

- Herpes simple (vesículas agrupadas, dolorosas).
- Eccema impetiginizado (dermatitis sobreinfectada).
- Varicela (lesiones en distintos estadios evolutivos).

3.2. Foliculitis

Definición

Inflamación **superficial del folículo piloso**, que afecta epidermis o dermis superficial.

Etiología

- **S. aureus** (principal).
- *Pseudomonas aeruginosa* (en jacuzzis o piscinas).
- *Candida* o *Malassezia* (en inmunosuprimidos).

Clínica

- Pápulas o **pústulas centradas en un folículo piloso**, con halo eritematoso.
- Dolor leve o prurito.
- Localización: cuero cabelludo, barba, glúteos, muslos, espalda.

Diagnóstico diferencial

- Acné vulgar (comedones presentes).
 - Quistes epidérmicos inflamados.
 - Piodermitis profundas (forúnculo).
-

3.3. Forúnculo (furúnculo)

Definición

Infección **profunda del folículo piloso**, con **absceso dérmico** y necrosis central.

Etiología

- **S. aureus** (incluyendo SAMR).

Clínica

- Nódulo doloroso, eritematoso, firme, con centro necrótico y exudado purulento.
- Puede drenar espontáneamente.
- Frecuente en cuello, axilas, glúteos, cara y muslos.
- Puede acompañarse de fiebre.

Diagnóstico diferencial

- Quiste sebáceo infectado.
 - Hidradenitis supurativa.
 - Absceso simple.
-

3.4. Ántrax cutáneo (carbúnculo estafilocócico)

Definición

Conjunto de **forúnculos confluentes**, con compromiso dérmico profundo y drenaje purulento múltiple.

Etiología

- **S. aureus** (más común).
- *Bacillus anthracis* (en carbunco zoonótico verdadero).

Clínica

- Placa inflamatoria indurada, caliente, con varios orificios de drenaje.
- Dolor intenso, fiebre, malestar general.
- Riesgo de bacteriemia o celulitis secundaria.

Diagnóstico diferencial

- Hidradenitis supurativa.
 - Abscesos múltiples.
 - Carbunco por *B. anthracis* (costra negra necrótica con edema masivo periférico, sin pus).
-

3.5. Celulitis

Definición

Infección **aguda del tejido celular subcutáneo** con extensión dérmica, que compromete extensas áreas.

Etiología

- **S. aureus** y **S. pyogenes**.
- En inmunodeprimidos: bacilos Gram negativos (E. coli, Pseudomonas).

Clínica

- Placa eritematosa, caliente, dolorosa, **de bordes difusos**.
- Edema, fiebre y compromiso general variable.
- Puede acompañarse de adenopatías regionales.

Diagnóstico diferencial

- **Erisipela** (bordes netos, más superficial).
- Tromboflebitis superficial.
- Paniculitis o dermatitis de contacto.

3.6. Erisipela

Definición

Infección **aguda y superficial** de dermis y linfáticos cutáneos.

Etiología

- **S. pyogenes** (grupo A β -hemolítico).

Clínica

- Placa **eritematosa brillante, de bordes bien definidos y sobreelevados**.
- Calor local, dolor, fiebre y malestar general.
- Localización típica: **cara y piernas**.

- Rápida progresión en horas.

Diagnóstico diferencial

- Celulitis (más profunda, bordes mal definidos).
- Eritema nodoso (nódulos subcutáneos, no infecciosos).
- Reacciones medicamentosas.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico suele ser **clínico**. Sin embargo, se recomiendan exámenes en casos graves, diseminados o recurrentes.

Examen	Indicaciones	Interpretación
Cultivo de exudado o pus	Impétigo, abscesos, ántrax	Identificación de agente y sensibilidad
Hemocultivos	Fiebre alta, celulitis extensa, inmunosupresión	Bacteriemia
Ecografía de partes blandas	Sospecha de absceso profundo	Colección líquida hipoeoica
Hemograma y PCR	Infecciones moderadas o graves	Leucocitosis y elevación de reactantes
Biopsia	Lesiones crónicas, ulceradas o refractarias	Confirmar vasculitis o neoplasia

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El tratamiento depende de la profundidad y gravedad del cuadro.

5.1. Medidas generales

- Higiene adecuada y lavado con agua y jabón neutro.
 - Evitar manipulación o rascado.
 - Compresas tibias y drenaje espontáneo si hay colección.
 - Aislamiento relativo en casos contagiosos (impétigo, forunculosis).
-

5.2. Tratamiento antibiótico

Infección	Tratamiento tópico / sistémico	Duración
Impétigo leve	Mupirocina 2% tópica o ácido fusídico 2% (2–3 veces/día)	5–7 días
Impétigo extenso o epidémico	Cloxacilina VO o cefadroxilo VO (500 mg/12 h)	7–10 días
Foliculitis leve	Higiene + mupirocina o peróxido de benzoilo	5 días
Forúnculo / ántrax	Compresas + drenaje; antibiótico oral si fiebre o riesgo (cloxacilina o clindamicina si SAMR sospechado)	7–10 días
Celulitis	Cloxacilina o cefazolina IV (moderada-grave); VO en casos leves	10–14 días
Erisipela	Penicilina G sódica IV o amoxicilina VO	10–14 días

Alternativas en alergia a penicilina:

- Clindamicina o macrólidos (azitromicina, claritromicina).
 - En sospecha de **SAMR comunitario**: trimetoprima-sulfametoxazol o doxiciclina.
-

5.3. Manejo hospitalario

- Infección extensa, fiebre alta o inmunocompromiso.
 - Celulitis con signos sistémicos (SIRS).
 - Sospecha de fascitis necrotizante o absceso profundo.
 - Fallo de tratamiento ambulatorio.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Infección	Complicaciones principales
Impétigo	Glomerulonefritis postestreptocócica (rara)
Foliculitis / forúnculo	Absceso, bacteriemia
Ántrax estafilocócico	Celulitis, sepsis
Celulitis / erisipela	Linfangitis, tromboflebitis, necrosis, shock séptico
Recurrentes	Portación nasal de <i>S. aureus</i> (requiere mupirocina intranasal)

Pronóstico:

Excelente con tratamiento adecuado. Riesgo aumentado de recurrencia en pacientes diabéticos o con insuficiencia venosa.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. El **impétigo** es la infección bacteriana **más frecuente en niños**; sus **costras melicéricas** son características.
2. **Celulitis**: bordes **difusos**; **erisipela**: bordes **netos y elevados**.
3. Siempre **drenar** abscesos antes de iniciar antibióticos.
4. Sospechar **SAMR comunitario** en lesiones purulentas recidivantes.
5. Evitar corticoides tópicos en infecciones bacterianas activas.
6. En EUNACOM, ante un niño con lesiones costrosas y prurito perioral → **impétigo no ampolloso**.
7. El tratamiento empírico inicial debe cubrir **S. aureus y S. pyogenes**.



Errores comunes

- Indicar antibióticos sistémicos innecesarios en impétigo leve.
- Confundir foliculitis con acné (presencia de comedones).
- No tratar portadores nasales en casos recurrentes.
- No distinguir clínicamente celulitis vs erisipela.
- Usar corticoides tópicos sin diagnóstico claro.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **infecciones bacterianas cutáneas** más frecuentes son impétigo, foliculitis, forúnculo, ántrax, celulitis y erisipela.
2. Los agentes más comunes son **S. aureus** y **S. pyogenes**.
3. La **profundidad de la infección** determina la gravedad clínica.
4. El diagnóstico es **clínico**, apoyado por cultivo si hay exudado o fracaso terapéutico.
5. **Mupirocina tópica** para impétigo; **penicilinas o cefalosporinas** para infecciones profundas.
6. Diferenciar **erisipela (bordes definidos)** de **celulitis (bordes difusos)** es esencial.
7. La educación en higiene y el tratamiento precoz **previenen recurrencias y complicaciones**.